

ΔΗΓΜΑ ΑΡΑΧΝΗΣ

Γενικά: Οι αράχνες είναι αρθρόποδα, που αριθμούν περισσότερα από 38.000 είδη, που τα περισσότερα θεωρούνται ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Ορισμένα είδη όμως, μετά από δήγμα, μπορεί να προκαλέσουν τοπικές βλάβες ή κλινικό σύνδρομο με ελαφρά ή βαρύτερη εικόνα.

Στην Ελλάδα, είδη αράχνης δυνητικά επικίνδυνα είναι το είδος **Loxosceles** που λέγεται «**αράχνη ερημίτισσα**» και προκαλεί κλινικό σύνδρομο που καλείται «**Λοξοσκελισμός**», το είδος **Latrodectus** ή «**μαύρη χήρα**» το δήγμα της οποίας προκαλεί «**Λατροδεκτισμό**» και το είδος **Lycossa** γνωστό κοινώς και ως «**σφαλάγγι**». Η μαύρη χήρα (*Latrodectus mactans*), ξεχωρίζει από το χαρακτηριστικό στίλβον μαύρο σώμα και το σχέδιο κόκκινης κλεψύδρας στην κοιλιά. Η Μεσογειακή μαύρη χήρα (*Latrodectus tredecimguttatus*) φέρει 13 κόκκινες κηλίδες στο ραχιαίο τμήμα της κοιλιάς, αλλά δεν έχει κοιλιακά κόκκινα σημάδια.



Η σύνθεση των τοξινών είναι διαφορετική στα διάφορα είδη αραχνών και χρησιμεύει στην εξουδετέρωση και εξωτερική πένση πριν τη βρώση του θηράματος. Το δηλητήριο της μαύρης χήρας είναι συνδυασμός πρωτεϊνών, πεπτιδίων και πρωτεασών. Η κύρια τοξίνη που βρίσκεται στο δηλητήριο της μαύρης χήρας είναι η α-Λατροτοξίνη (α-LTX) η οποία είναι μια νευροτοξίνη και ευθύνεται για την αθρόα έκλυση νευροδιαβιβαστών στον οργανισμό μετά από δήγμα (π.χ. *Ντοπαμίνη*, *νορ-Αδρεναλίνη*, *Ακετυλοχολίνη*, *Γλουταμικό* και *GABA*). Το δηλητήριο της *Loxosceles* (*Lox. reclusa* και *Lox. rufescens*) αποτελεί μίγμα 8 ενζύμων (π.χ. *αλκαλική φωσφατάση*, *εστεράση*, *υαλουρονιδάση* και κυρίως *σφιγγομυελινάση D*, κ.ά.).

Κλινική εικόνα: Το τυπικό δήγμα της μαύρης χήρας είναι μια ήπια λευκοπή δερματική βλάβη, που περιβάλλεται από μια περιμετρική κόκκινη άλω γύρω από το σημείο δήγματος. Ενώ, το δήγμα της καφέ αράχνης *Loxosceles*, προκαλεί δερματική βλάβη με 3 ομόκεντρες κεντρομόλες ζώνες ερυθήματος, ισχαιμίας και νέκρωσης. Οι συστηματικές εκδηλώσεις του **Λατροδεκτισμού** ξεκινούν 20-120 λεπτά μετά το δήγμα και είναι εφίδρωση, σιελόρροια, δακρύρροια, βρογχόρροια, έμετοι, έντονο άλγος στην κοιλιά και οσφύ, μυικές συσπάσεις, κεφαλαλγία, ταχυκαρδία, υπέρταση, οίδημα προσώπου, αναπνευστική δυσχέρεια, σπασμοί. Ο **Λοξοσκελισμός** εμφανίζει δυσφορία, κεφαλαλγία, αρθραλγίες, πυρετό, έμετο, αιμόλυση, ραβδομύωση, υπόταση, οξεία νεφρική βλάβη, θρομβοπενία, ΔΕΠ, εξάνθημα, σπασμούς.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Επί συστηματικής νόσου ελέγχουμε τα A, B, C, D, E του ασθενούς. Εξασφαλίζουμε τον αεραγωγό, την οξυγόνωση και τοποθετούμε ευρείες (#16 G) 3-way φλεβικές γραμμές.
2. Εφαρμόζεται καρδιακό monitoring (*ΗΚΓ*) κι ελέγχουμε συνεχώς τα ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂, T °C*) και το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή τον αλγόριθμο AVPU.
3. Διενεργούμε τοπικό καθαρισμό στο σημείο του δήγματος, ήπια, με νερό και σαπούνι.
4. Χορηγείται αναλγησία με 1 amp. Dynastat 40 mg (ή 1 amp. Vialaxal 50 mg), ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως σε 100 ml N/S και ήπια μυοχαλάρωση με 1 amp. Musco-Ril (ή Norflex) (im).
Επικουρικά για αναλγησία: 1 amp. Apotel-plus (im) ή fl. 100 ml Apotel 1 gr (iv).
5. Μεριμνούμε για γαστροπροστασία με χορήγηση 1-2 amp. Σιμετιδίνης 200 mg (Tagamet) εντός 100 ml N/S ή/και ενός ενέσιμου PPI (1 amp. Nexium/Lordin) σε iv-bolus έγχυση.
6. Ανοσοποιούμε για τέτανο: HTIG - inj. sol. Tetagam-P 250 IU, ενδομυϊκώς (im), άπαξ.
7. Επί εμφανίσεως μυικών σπασμών ή δεσμιδώσεων (σε δήγμα μαύρης χήρας) χορηγούμε βραδέως-iv Διαζεπάμη, ήτοι 1-2 amp. Stedon 10 mg, διαλυμένη σε ορό 100-250 ml N/S.
8. Επικοινωνία με τον ΕΟΦ για εξασφάλιση αντιαραχνικού ορού (*anti-Latrodectus*), αφού προηγηθεί test ευαισθησίας: 1-2 vials Antivenin, εντός 100 ml N/S ή D₅W, σε 60 λεπτά.
9. Σε έντονη δερματική αντίδραση - επί δήγματος *Loxosceles* - χορηγούνται συστηματικώς αντιϊσταμινικά, ήτοι 1 amp. Διμεθινδένη (Fenistil) σε 100 ml N/S (iv), σε 15-20 λεπτά.
10. Σε σοβαρή φλεγμονώδη/νεκρωτική δερματική βλάβη (*δερματικός Λοξοσκελισμός*) εκτός από αντιισταμινικά χορηγούνται (iv ή po) και αντιβιοτικά (*Amox/Clav, Flagyl, Ciproxin*).